4.6.1. 의약품부작용 모니터링 및 약물 알레르기 관리

제 정 일	2009.09.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	의약품부작용감시위원회, 약무국				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 4.6 의약품부작용 모니터링 JCI Standard 7th Edition: MMU.7, 7.1

제1조 (목적)

1. 환자의 약물 효과를 모니터링하여 의약품부작용 및 약물 알레르기를 원내 보고절차에 따라 보고하고, 이를 분석 및 관리하여 동일한(또는 예측 가능한) 의약품부작용이나 약물 알레르기 반응의 위험으로부터 환자를 보호하고, 분석 결과를 관련 직원과 공유하여 약물 안전사용을 증진시키기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 의약품부작용(Side Effect): 의약품 등을 정상적인 용량에 따라 투여할 경우 발생하는 모든 의도되지 않은 효과를 말하며, 의도되지 않은 바람직한 효과도 포함한다.
2. 약물이상사례(Adverse Event/Adverse Experience, AE): 의약품 등을 투여, 사용 중 발생한 바람직하지 않고 의도되지 않은 징후, 증상 또는 질병을 말하며, 반드시 인과관계를 가져야 하는 것은 아니다.
3. 약물이상반응(Adverse Drug Reaction, ADR): 의약품 등을 정상적으로 투여, 사용하여 발생한 유해하고 의도하지 아니한 반응으로서 해당 의약품등과의 인과관계를 배제할 수 없는 경우
4. 중대한 이상사례·약물이상반응(Serious Adverse Event/Adverse Drug Reaction): 약물 이상사례·약물이상반응 중 다음 각 항목 중 어느 하나에 해당하는 경우
   1) 사망을 초래하거나 생명을 위협하는 경우
   2) 입원 또는 입원기간의 연장이 필요한 경우
   3) 지속적 또는 중대한 불구나 기능저하를 초래하는 경우
   4) 선천적 기형 또는 이상을 초래하는 경우
   5) 기타 의학적으로 중요한 상황
5. 약물 알레르기 및 약물이상반응 과거력 등록: 환자의 약물 알레르기 이력 및 약물부작용 과거력을 원내 의약품부작용보고 절차에 따라 입력하여 동일한 약물 알레르기 반응 및 약물부작용의 위험으로부터 환자를 보호하기 위한 등록 시스템

제3조 (절차)

1. 의약품 투여 환자 모니터링
   1) 의료진은 환자가 과거에 경험한 의약품부작용 또는 알레르기 병력에 대해 확인하여 기록한다.
   2) 의료진은 약물을 투여받는 환자의 약물 효과(기대되는 치료적 반응), 알레르기 반응,

예상치 않은 약물 간 상호작용, 부작용 등을 모니터링하고 필요할 경우 기록한다.

3) 환자에게 새로운 약품에 대해 처음으로 투여를 할 경우, 환자 반응을 면밀히 모니터링 한다.

2. 의약품부작용 발견 및 보고

1) 보고대상

(1) 의약품부작용으로 의심되는 모든 사례

(2) 중대한 약물 이상사례·이상반응

2) 보고자: u-Severance에 접근할 수 있는 의사, 약사, 간호사, 방사선사, 보건의료정보관리사 등

3) 의약품부작용보고절차

(1) 원내보고

① 환자에게 발생한 의약품부작용의 경우 u-Severance에서 '의약품부작용보고'를 통해 전산으로 보고한다. 특히 중대한 이상사례·이상반응은 처음 확인한 의사 또는 간호사가 24시간 이내 보고한다.

② 환자에게 발생한 의약품부작용 또는 약물 알레르기 반응은 의무기록에 기록한다.

③ 원내에서 발생한 중대한 약물 이상사례·이상반응은 의약품부작용감시위원회에서 병원장 결재를 득하여 신속하게(발생 인지일로부터 15일 이내) 한국의약품안전관리원으로 보고하고, 의약품부작용감시위원회에서 심의한다.

(2) 원외보고

① 원내에서 발생한 약물이상사례, 이상반응은 의약품부작용감시위원회를 통해 한국의약품안전관리원에 보고한다.

(3) 지역보고

① 지역(원외)에서 발생한 의약품부작용은 관련법을 준수하여 한국의약품안전관리원 또는 세브란스지역의약품안전센터를 통해 보고한다.

(4) 원내 사용이 승인된 신약에 대한 의약품부작용 보고 절차

① 신약을 신청한 의사가 약사위원회가 정한 모니터링 기간 동안 투여 후 반응을 관찰하고, 정해진 신약모니터링 양식에 기록하여 의약품부작용감시위원회에 제출한다. 발생한 약물 부작용은 이와 별도로 의약품 보고 절차에 따라 보고한다.

3. 의약품부작용 모니터링

1) 의약품부작용 모니터링 절차: 부작용 발견 → 보고 → 모니터링(검토) → 분석 → 평가

4. 의약품부작용 분석 및 평가

1) 의약품부작용 평가 방법

(1) 평가 방법: 의약품부작용 평가위원은 투여한 의약품과 부작용 간의 인과성 여부를 확인하기 위해 환자의 의무기록 및 검사 결과를 검토, 분석, 평가하고 해당 약품의 기 보고된 부작용 내역을 확인하며, 필요시 제약회사에 관련 자료를 확인한다.

(2) 평가 담당자 자격: 의약품부작용감시위원회에서 정한 의약품부작용 평가위원이 모니터링 각 단계별 업무를 수행하며, 적절한 교육을 받은 약사와 알레르기내과 등의

전문분야의 의사가 수행한다.

(3) 평가 결과 기록: 분석, 평가한 결과는 다음의 사항을 포함한 보고서의 형태로 원내 의약품부작용 보고 절차에 따라 기록한다.

① 보고서에 포함되어야 할 항목: 환자정보, 대상 약품정보, 부작용 발생 시 의료진 조치사항 및 의견, 약무국 검토의견, 인과성 평가 결과 및 향후 개선사항 등

5. 의약품부작용 보고결과 평가 및 관리

1) 의약품부작용 인과성평가 결과 'Possible' 이상의 사례는 의약품부작용감시위원회에서 u-Severance의 알림창 적용 여부를 결정한다.

2) 의약품부작용 보고 사례 및 알레르기 등록 내용이 있는 환자의 경우 u-Severance에 'A(Alert)'를 표시하여 처방 또는 의약품 투여 시 확인하도록 한다.

3) 의사가 부작용이 발생한 약물과 동일 계열 성분을 처방할 경우, 의약품부작용 보고 및 평가 내용을 알림창으로 공지한다.

4) 의약품부작용을 경험한 환자에게 의약품부작용 정보 제공을 위해 필요하다고 판단될 경우에는 '약물안전 카드'를 발급할 수 있다.

(1) 발급권한: 의사 또는 의약품부작용감시위원회

(2) 발급기준

① 인과성 평가 결과 'Probable' 이상인 의약품부작용 의심 약물

② 환자가 인지하고 있는 확실한 의약품부작용 과거력

③ 중대한 이상사례·이상반응

5) 중대한 이상사례 발생 환자를 위한 한국의약품안전관리원의 '의약품부작용 피해구제 사업'에 대해 안내할 수 있다.

6. 의약품부작용에 대한 경영진 보고 및 직원 공유

1) 의약품부작용 보고 현황 및 결과는 의약품부작용감시위원회를 통해 병원장에게 보고한다.

2) 의약품부작용 보고 결과를 분석하고 관리하며 관련 직원과 해당 내용을 공유한다.

3) 의약품부작용 모니터링을 통해 수집된 사례를 분석하여 안전한 약물사용을 위한 자료로 활용한다.

(1) 원내외 공지

(2) 식품의약품안전처에서 배포한 안전성 서한 공지

(3) 의약품부작용감시위원회에서는 안전성에 문제가 있다고 판단되는 약품에 대해 약사위원회에 사용 중단을 요청할 수 있다.

제4조 (부록)

1. AATRA(Acute Assessment & Treatment of Radiocontrast media Allergy) Protocol

제5조 (참고)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2009년 9월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)